VADEMECUM

Psicologo Digitale

La stanza d'ascolto · guida tascabile

Colloquio preliminare con Neura, 6 questionari di autovalutazione, percorso in 8 tappe, 12 esercizi guidati e relazione per il professionista. Anche senza connessione, senza account e senza che nulla esca dal dispositivo.

Ideato, scritto e sviluppato da **Danilo D'Auria**
un progetto **FeniceOS**

Versione 1.3.2 · https://danilodauria.github.io/psicologo-digitale/
Codice MIT · Contenuti CC BY-NC-SA 4.0

Questo programma è educativo e di orientamento. Non formula diagnosi, non prescrive terapie e non sostituisce uno psicologo, uno psicoterapeuta o un medico. In caso di emergenza chiama il **112**.

Indice

Le pagine che seguono sono pensate per essere stampate e tenute accanto al computer, oppure lette sul telefono. Ogni sezione si chiude con quello che conviene portare a un professionista.

Che cos'è e che cosa non è 3

In dieci minuti 4

I questionari 5

Il percorso in 8 tappe 7

Segnali d'allarme e numeri utili 9

Nutrizione e umore 11

Installala e usala offline 13

Privacy, backup, licenze 14

Da portare al professionista 14

Che cos'è e che cosa non è

Psicologo Digitale è una **pre-analisi guidata**: serve a mettere in ordine ciò che senti prima di parlarne con qualcuno, a misurare l'intensità di alcune aree e ad arrivare al primo colloquio con parole più precise. Non è una terapia, non è una diagnosi e non è un test psicologico validato.

Che cosa fa

- conduce un colloquio adattivo in 8 fasi (62 domande possibili);
- propone 6 questionari di autovalutazione con punteggi, fasce e lettura clinica;
- organizza un percorso in 8 tappe con 12 esercizi guidati;
- genera una relazione PDF da consegnare a chi può valutare davvero.

Che cosa non fa

- non formula diagnosi e non sostituisce un professionista;
- non prescrive farmaci, dosi o terapie;
- non gestisce emergenze: per quelle c'è il 112;
- non invia nulla in rete: i dati restano nel browser del dispositivo.

Una regola semplice. Se ti accorgi di usare il programma per rimandare la telefonata a uno psicologo, hai già la risposta: quella telefonata è il passo successivo.

In dieci minuti

Non serve completare tutto. Il modo più utile per iniziare è questo, e si può interrompere in qualsiasi momento: le risposte restano salvate sul dispositivo.

1. Leggi l'avvertenza e dai il consenso.
2. Fai il colloquio: rispondi di getto, senza cercare la risposta «giusta».
3. Compila uno o due questionari, quelli che riguardano l'area che ti pesa di più.
4. Guarda il quadro che emerge: aree, intensità, segnali da non ignorare.
5. Genera la relazione e portala con te, oppure scegli una tappa del percorso.

Il colloquio, in pratica

Le fasi sono 8 e seguono un ordine preciso: prima si accoglie, poi si esplora il motivo, poi si approfondisce per area, si ricostruisce la storia, si guarda il funzionamento quotidiano, si controlla la sicurezza, si cercano le risorse e infine si restituisce una sintesi. Se una domanda ti mette a disagio, puoi saltarla: non è un esame.

Fase	Che cosa esplora
1	Accoglienza
2	Motivo
3	Approfondimento
4	Storia
5	Funzionamento
6	Sicurezza
7	Risorse e obiettivi
8	Restituzione

I questionari

Sono indicatori di intensità, non strumenti diagnostici: non hanno valore di test psicometrico validato e non definiscono chi sei. Servono a capire quanto un'area pesa, nelle ultime due settimane, e a dare al professionista un punto di partenza concreto.

Questionario	Item	Punteggio max
Umore, interesse e piacere	9	27
Ansia, tensione e preoccupazione	7	21
Stress percepito	10	40
Sonno e recupero	7	28
Esaurimento e carico di lavoro	8	32
Benessere generale	5	100

A che cosa serve ciascuno

Umore, interesse e piacere. Esplora il tono dell'umore, l'interesse, l'energia e la fiducia in sé. È l'area che più spesso accompagna ansia, stress e cambiamenti di vita.

Ansia, tensione e preoccupazione. Distingue la preoccupazione fisiologica da quella che occupa la giornata, disturba il sonno e spinge a evitare situazioni.

Stress percepito. Misura quanto la vita ti sembra imprevedibile, fuori controllo o sovraccarica: un fattore che influenza sonno, umore e salute fisica.

Sonno e recupero. Il sonno è il primo segnale che cambia in ansia, umore basso e burnout. Migliorarlo spesso migliora tutto il resto.

Esaurimento e carico di lavoro. Il burnout non è una malattia ma un fenomeno legato al lavoro: esaurimento, distacco mentale ed efficacia ridotta. Riconoscerlo presto cambia le scelte possibili.

Benessere generale. Non misura solo i sintomi: guarda a vitalità, interesse e piacere. Serve a bilanciare il quadro e a vedere le risorse, non solo le difficoltà.

Attenzione. Se un questionario contiene una domanda sui pensieri di morte e la risposta è affermativa, il programma mostra subito i numeri utili. Non è un eccesso di prudenza: è la parte più importante di tutto il percorso.

Il percorso in 8 tappe

Circa sedici settimane, con una pratica settimanale e un indicatore per capire se sta funzionando. Non è obbligatorio seguirlo in ordine: scegli la tappa che corrisponde al tuo momento.

Tappa	Titolo	Obiettivo
1	Orientarsi	Passare dal «sto male» a una descrizione condivisa: che cosa succede, da quando, quanto interferisce, che cosa lo mantiene.
2	Ritrovare il corpo	Ridurre l'attivazione fisiologica e ristabilire le condizioni di base: sonno, luce, movimento, caffeina.
3	Ricominciare a fare	Rompere il circolo «non ho voglia → non faccio → sto peggio» con azioni piccole, programmate e realistiche.
4	Guardare i pensieri	Distinguere fatti e interpretazioni, riconoscere le distorsioni e costruire letture più accurate.
5	Reggere le emozioni	Aumentare la capacità di stare con emozioni intense senza evitarle e senza esserne travolti.
6	Confini e relazioni	Esprimere bisogni e limiti in modo chiaro, riducendo conflitti inutili e senso di colpa.
7	Direzione e valori	Collegare le azioni quotidiane a ciò che conta, per sostenere la motivazione oltre il sintomo.
8	Consolidare	Riconoscere i segnali precoci, avere un piano scritto e sapere quando chiedere aiuto.

Gli esercizi

Sono pratiche brevi, da fare quando servono e non per dovere. Se un esercizio ti fa stare peggio, smetti e parlane con il professionista: anche le tecniche hanno controindicazioni.

Esercizio	Durata	Quando
Respiro lento 4-6	5 minuti	Prima di dormire, prima di una situazione temuta, quando senti il corpo in allarme.
Ancoraggio 5-4-3-2-1	5 minuti	Attacchi di panico, rimuginio intenso, sensazione di irrealtà.

Esercizio	Durata	Quando
Attivazione comportamentale	10 minuti di pianificazione	Ritiro, apatia, giornate che si svuotano.
Scheda del pensiero	15 minuti	Un pensiero ti ha fatto stare male e vuoi capirlo.
Finestra della preoccupazione	10 minuti	Preoccupazioni che tornano durante il giorno o prima di dormire.
Sonno: le sei regole	10 minuti	Insonnia lieve o sonno irregolare.
Pausa di autocompassione	8 minuti	Dopo un errore, un rifiuto, una giornata in cui ti sei giudicato/a duramente.
Una conversazione difficile (DESC)	15 minuti	Un conflitto che si ripete, un favore che pesa, un limite da mettere.
Bussola dei valori	20 minuti	Confusione, mancanza di motivazione, sensazione di vivere per gli altri.
Rilassamento muscolare progressivo	15 minuti	Tensione cronica, difficoltà a rilassarsi, prima di dormire.
Camminata consapevole	15 minuti	Giornate sedentarie, testa piena, bisogno di staccare.
Piano di mantenimento	20 minuti	Fine del percorso e ogni volta che ti senti più stabile.

Segnali d'allarme e numeri utili

Se c'è un pericolo immediato per la tua vita o per quella di un'altra persona, chiama il 112. Non aspettare di avere le parole giuste: il 112 risponde anche per emergenze psicologiche.

Segnali da non ignorare

- Pensieri ricorrenti che sarebbe meglio non esserci, o di farsi del male.
- Un piano preciso, l'accesso a mezzi, o un tentativo già avvenuto.
- Sentirsi un peso per gli altri, isolarsi, regalare cose, salutare come se fosse un addio.
- Non dormire, non mangiare, non riuscire più a svolgere le attività di base per giorni.
- Sentire voci o credere cose che gli altri non vedono, con paura o disorganizzazione.
- Subire minacce, percosse, controllo o isolamento da parte di qualcuno.
- Bere o usare sostanze in modo che mette a rischio la propria sicurezza.
- Dolore al petto, fiato corto nuovo, svenimenti: valutazione medica urgente.

Cosa fare subito

1. Se il pericolo è immediato: chiama il 112 e resta in linea. Se puoi, non restare solo/a.
2. Se pensi al suicidio: dillo a una persona di fiducia e a un professionista. Non è un segreto da custodire.
3. Allontana o fai allontanare i mezzi per farsi del male, se è possibile farlo in sicurezza.
4. Se subisci violenza: 1522. Se sei in pericolo immediato: 112. Esistono centri antiviolenza e case rifugio.
5. Se sei un minore: parla con un adulto di fiducia, chiama il 19696 o il 114.
6. Non usare alcol o sostanze per gestire la crisi: peggiorano il controllo degli impulsi.
7. Dopo una crisi, chiedi un appuntamento con il medico o con un professionista della salute mentale.

Numero	Servizio	A che cosa serve
112	Emergenza unica europea	Da qualsiasi telefono, anche senza credito. Per pericolo immediato.
02 2327 2327	Telefono Amico Italia	Ascolto per chi attraversa un momento difficile. Tutti i giorni.
06 77208977	Samaritans Onlus	Ascolto per chi è in crisi o ha pensieri suicidari. Attivo tutti i giorni, 13-22.
19696	Telefono Azzurro	Bambini e adolescenti, 24 ore su 24. Anche chat sul sito.
1522	Numero antiviolenza e stalking	Gratuito, multilingue, 24 ore su 24. Anche chat e app.
114	Emergenza infanzia	Emergenze che coinvolgono minori.

In pericolo immediato: 112. Non serve avere le parole giuste e non serve aspettare. Se il rischio riguarda un'altra persona, non lasciarla sola e aiutala a chiamare.

Nutrizione e umore

Mangiare non è solo carburante: è sonno, energia, umore, digestione, relazioni e spesso anche il modo in cui ci prendiamo cura di noi. Questa sezione non ti dà una dieta e non ti dice cosa devi pesare. Serve a capire cosa conta davvero, quali domande portare a chi è competente e quando il cibo smette di essere un piacere e diventa una preoccupazione.

Cinque cose che contano

La regolarità conta più della perfezione. Il corpo lavora meglio con orari stabili: colazione, pranzo, cena e, se serve, uno spuntino. Saltare i pasti per rimediare a un pasto abbondante è la mossa che più spesso peggiora fame, umore e sonno. Non esiste il pasto «sbagliato» da espiare.

Il modello mediterraneo regge il confronto. È uno dei modelli alimentari più studiati: verdure e frutta in abbondanza, legumi, cereali integrali, pesce, olio d'oliva, frutta secca; carne rossa e dolci con moderazione. Non è una moda: è una tradizione con alle spalle anni di osservazione.

La fibra parla con l'intestino e con l'umore. Legumi, cereali integrali, verdura e frutta nutrono la flora intestinale. Le indicazioni italiane parlano di circa 25 grammi al giorno per un adulto; la maggior parte delle persone ne mangia meno della metà. Si aumenta piano, bevendo di più.

Caffeina e alcol si sentono sul sonno. La caffeina resta in circolo per ore: un caffè alle 17 può pesare alle 23. L'alcol fa addormentare prima ma frammenta la seconda metà della notte, e il sonno perso si ripercuote su umore e fame del giorno dopo.

Muoversi e vedere la luce del mattino. Non è nutrizione, ma lavora sullo stesso sistema: una camminata e venti minuti di luce naturale al mattino aiutano ritmo sonno-veglia, appetito e tono dell'umore. Vale più di qualsiasi integratore.

Chi consultare

Figura	Quando serve
Dietista	Quando serve un piano concreto e un accompagnamento nel tempo, anche attraverso il servizio pubblico.
Dietologo	Quando c'è una malattia da gestire, un peso che mette a rischio la salute o più problemi insieme.

Figura	Quando serve
Biologo nutrizionista	Quando serve un percorso nutrizionale in studio privato, senza patologie mediche da trattare.
Medico di medicina generale	Sempre, come punto di partenza, e obbligatoriamente se ci sono sintomi fisici o farmaci in corso.
Psicologo o psicoterapeuta	Quando il cibo è diventato un modo per gestire emozioni, o quando è stato diagnosticato un disturbo alimentare.

Quando non aspettare

- Perdita o aumento di peso involontario, superiore al cinque per cento in un mese.
- Restringere sempre di più ciò che mangi, contare calorie o grammi in modo ossessivo, saltare pasti in modo ricorrente.
- Abbuffate con la sensazione di perdere il controllo e, dopo, vergogna o comportamenti di compenso.
- Vomito autoindotto, uso di lassativi o diuretici, esercizio fisico usato per «bruciare» ciò che hai mangiato.
- Paura intensa di ingrassare che condiziona scelte, uscite e relazioni.
- Il pensiero del cibo occupa gran parte della giornata e ti impedisce di fare altro.

Se riconosci anche solo uno dei primi sei segnali, non aspettare: parlane con il medico di base o con un centro per i disturbi dell'alimentazione della tua azienda sanitaria. Non è un problema di volontà e non si risolve con forza di carattere. Per un malessere improvviso chiama il 112.

Installala e usala offline

Non c'è un negozio di applicazioni e non serve: è una PWA e si installa dal browser in pochi secondi. Dopo la prima apertura funziona anche senza connessione.

Android (Chrome)

Menu ■ in alto a destra → **Installa app** (su alcuni telefoni **Aggiungi alla schermata Home**).

iPhone e iPad (Safari)

Tocca **Condividi**, scorri e scegli **Aggiungi alla schermata Home**.

Computer (Chrome o Edge)

L'icona di installazione compare nella barra degli indirizzi; in alternativa menu ■ → **App** → **Installa questo sito come app**. Su Safari per Mac: **File** → **Aggiungi al Dock**.

La barra in alto

Sotto l'intestazione c'è una barra sempre visibile: dice se stai usando il browser, la PWA installata o il programma per computer, se Ollama risponde, se il microfono è pronto e come attivarlo, e offre **Ferma l'audio** e **Indietro**. In fondo alla barra, **Aiuto subito** mostra 112, 1522 e Telefono Azzurro: sono a un tocco da qualsiasi pagina.

Un modello locale, se ti va

Neura funziona da sola. Se vuoi anche un modello generativo sul tuo computer puoi installare **Ollama**, gratuito e open source: la pagina *Installa* riconosce sistema e memoria, propone il pacchetto giusto e il modello adatto, e verifica il collegamento locale. Resta un extra: Neura non lo usa e le risposte verificate restano le sue.

Modello	Spazio	Memoria
qwen2.5:1.5b	circa 1 GB	almeno 4 GB
llama3.2:3b	circa 2 GB	almeno 8 GB
qwen2.5:7b	circa 4,7 GB	almeno 16 GB
qwen2.5:14b	circa 9 GB	almeno 32 GB

Privacy, backup, licenze

Non c'è un account e non c'è un server. Risposte, questionari, diario e relazione restano nel *localStorage* del browser, su quel dispositivo. Nessuna telemetria, nessuna pubblicità, nessun dato inviato a terzi.

Che cosa sapere

- se cancelli i dati del browser, i dati spariscono: esporta un backup JSON dalla sezione Licenze;
- la relazione PDF viene generata sul dispositivo e condividerla dipende solo da te;
- i dati sono sensibili: conserva il backup in un luogo protetto, non in una cartella condivisa.

Licenze

Codice con licenza **MIT**. Contenuti, testi, questionari, esercizi e grafica con licenza **Creative Commons BY-NC-SA 4.0**: attribuzione, non commerciale, stessa licenza. «Psicologo Digitale» e «Neura» sono di Danilo D'Auria, un progetto FeniceOS.

Fonti principali

- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) — https://www.psy.it/
- Ministero della Salute — https://www.salute.gov.it/
- Istituto Superiore di Sanità — https://www.iss.it/
- NICE — https://www.nice.org.uk/
- Organizzazione Mondiale della Sanità — https://www.who.int/
- DSM-5-TR — https://www.psychiatry.org/
- Telefono Amico Italia — https://www.telefonoamico.it/
- 1522 — https://www.1522.eu/
- Telefono Azzurro — https://azzurro.it/

Da portare al professionista

- la relazione PDF stampata, con punteggi e aree emerse;
- le date e i momenti in cui il problema si è fatto sentire di più;

- i farmaci che prendi e le sostanze che usi, senza vergogna;
- le domande che ti sei scritto, anche quelle che sembrano banali;
- una persona di fiducia, se ti aiuta non andare da solo.

Vademecum di Psicologo Digitale · versione 1.3.2 · https://github.com/danilodauria/psicologo-digitale
Stampato o letto, questo opuscolo non sostituisce una valutazione professionale.